

إسم المريض ربيعاً : خديجه عطيه احمد عطيه

المحافظة : الجيزة

الحي / المدينة : اوسيم

العنوان : ~~

رقم البطاقة : 26802182100967 رقم التليفون : 01068312268

تاريخ تسجيل الإستمارة : 23-09-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 18-02-1968 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات الاروماتيز [14161]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

تتعمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- /د ----- /د ----- /د.ا ----- /د.ا

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج :-

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: خديجه عطيه احمد عطيه National ID: 26802182100967	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





MDT FORM

Name:	Khadija Atiah Mohamoud Ali	MRN:	6119
Age:	58 Y	ID:	26802182100967
Menopausal Sta	Postmenopausal	Phone:	01110721918
NRS SCORE:		Marital Status:	01125343398
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:	HTN	Reason Of MDT:	ttt vs surgery

Clinical Data:

BX:	ILC G2
ER:	8/8
PR:	4/8
HER2:	0
KI67:	25%

Sonomammography:
Rt breast retroareolar lesion 27 x 13 mm - Rt axillary LN Level 1

Mets Workup:
CT CAP: query L1-4-5 vertebral lesions? pending bone scan

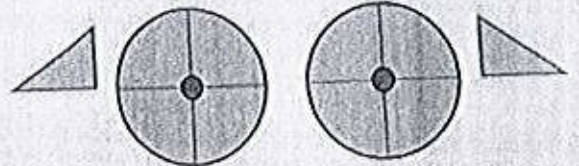
History:

Recommendations:
Start AI till bone scan availability and decide on surgery

MDT Outcome & Plan
Start AI till bone scan availability and decide on surgery

R

L



T N M

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>				



رسوم الاستعلام 20 جنية

جبهه الاصدار : فرع الجيزة

تاريخ الاصدار : 2025-12-14

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعينه .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعى
والبحث تبين أن

السيد (ة) خديجه عطيه احمد عطيه بطاقة رقم 26802182100967

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعيه يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة : 2025-12-14



افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد.....

مسلسل 1852403



الخطاب ماري لعدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمي

Patient Name : الأستاذة / خديجة عطيه احمد
Patient No. : 26802182100967
Path No. : 3879/25
Sex : Female
Age : 57 Y
Referring Doc :

Request No. : 13003989
Request Date : 16/12/2025
Verification Date : 28/12/2025
Financial Category : جوستاف روسي - مبادره
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical data

Right breast retroareolar lesion with pathological lymph nodes .

Nature of specimen

Tru cut biopsy, collected on 16/12/2025, at 12:10 p.m , cold ischemia time is 5 minutes .

Gross examination

Multiple(3) grayish white tissue cores ranging in size from 0.5 up to 1 cm, totally submitted.

Microscopic examination

- * Histological type: Invasive lobular carcinoma.
- * Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II
- * DCIS: Absent
- * Angioinvasion: Absent
- * Perineural invasion: Absent
- * Microcalcification : Absent

Diagnosis

Right breast retroareolar suspicious lesion , Tru cut biopsy:
Invasive lobular carcinoma, Grade II.
For further IHC (ER, PR, HER2, Ki67)

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim
Dr.Heba El-Shafeey

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 28/12/2025 13:38:17

Page 1 of 2

Printing By : Dr.Heba Hasan



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / خديجة عطيه احمد
Patient No. : 26802182100967
Path No. : 3879/25
Sex : Female
Age : 57 Y
Referring Doc. :

Request No. : 13003989
Request Date : 16/12/2025
Verification Date : 25/12/2025
Financial Category : جوستاف روسي - مبادره
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Right breast mass.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy.

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultraview HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) and Ki67 clone (30-9).

Results:

- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (Allred score 8/8).
- PR: Moderate nuclear reaction in 5 % tumor cells (Allred score 4/8).
- Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67: 25 %.

Conclusion:

Right breast cancer, Tru-cut biopsy:
Invasive lobular carcinoma, Grade 2
IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive(score 4/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67: 25 %

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Printing Date : 28/12/2025 13:34:31

Page 1 of 2

Printed By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name الأستاذ / خديجة عطيه احمد
Patient No. 26802182100967
Path No. 3879/25
Sex Female
Age 57 Y
Referring Doc.

Request No. 13003989
Request Date 16/12/2025
Verification Date 25/12/2025
Financial Category جوستاف روسي - مبادره
Department Out Patient
Registered by Mrs.Mayada Hegazy

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Dr.Walaa Ibrahim Ghoneim
Dr.Heba El-Shafeey

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Printing Date : 28/12/2025 13:34:31

Page 2 of 2

Printed By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Name : khadiga attia ahmed
Branch : Portable
Ref.Physician Prof :

Date : 14-01-2026 02:37
Medical No. : GRI-26802182100967
Ins.Company :

**MULTISLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**

I- CHEST:

- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.
- **Right axillary suspicious lymph node measuring 2x1 cm**
- **Right breast Retroareolar suspicious lesion measuring 3x2.5 cm**
- Unremarkable left breast and left axilla.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- The liver shows homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses, diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

III. SURVEYED SKELETON:

- Query suspicious sclerotic lesions at L2, L4 and L5 vertebral bodies
- Osteodegenerative changes are noted.

Conclusion:

- **Right breast & right axillary suspicious lesions for further sonomammographic correlation**
- **Multilevel lumbar spine query suspicious sclerotic lesions for follow up.**

Much Obligated;
Dr. Zeinab Aly, MD

Name : Khadija Atieh Ahmed Atieh
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Date : 11-09-2026 01:25
Medical No. : 459275
تعاقب مستشفى : Ins.Company

Tc-99m MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History

58 year-old female patient, who gave history of right breast cancer complains of bone pain and referred for metastatic work up.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of 20 mCi of the tracer.

Findings

- No evidences of osseous tracer uptake abnormalities that would account for bone secondaries.
- Degenerative features are depicted at different levels of the spine and around big joints.

IMPRESSION:

- No definite osseous metastasis could be depicted on scintigraphic basis.

Much obliged
Dr. Alaa Nagy, MD,
Nuclear medicine